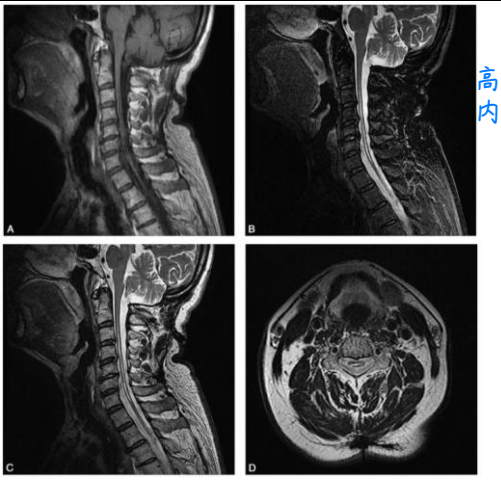
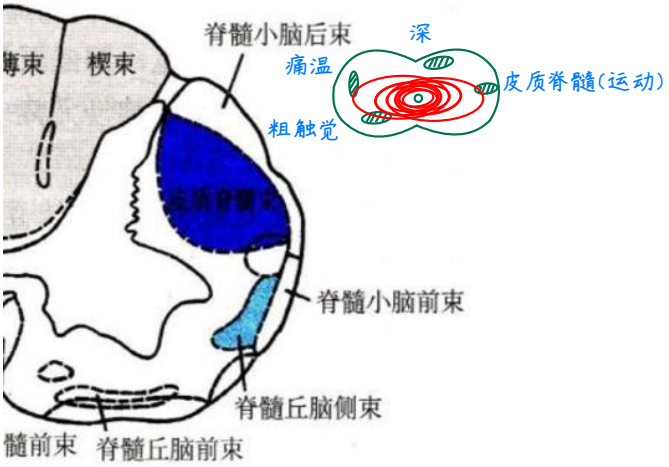
VS 肺上沟瘤:卡压到臂丛神经根,会有肩膀、上肢的感觉运动障碍

4.鉴别诊断

颈椎病	出口窄会压迫臂丛神经根和锁骨下A 鉴别 肘管综合征:尺神经被卡压 腕管综合征:正中神经被卡压	ttsx
臂丛神经被卡压了 神经根型	胸廓出口综合征、周围神经卡压综合征	VS 脊髓中央管周围综合征:没有感觉分离(急性期)
脊髓型	脊髓空洞症 肌萎缩侧索硬化/渐冻症	脊髓空洞症：感觉分离——痛温觉消失、而触觉及深感觉存在（心已空不知冷暖）
交感神经、椎动脉型	美尼尔病（感动你）	美尼尔病：反复发作听力下降、旋转性眩晕



高信号:空腔,内积聚液体



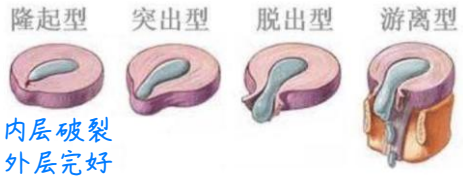
三、腰椎间盘突出症

颈椎病不仅有颈椎间盘突出,还有颈椎骨质增生、韧带钙化等问题都会对神经根造成压迫刺激,所以统称为颈椎病

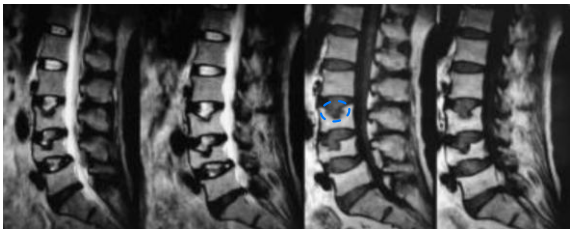
1.L_{4-5}、L_5-S_1好发，男性多见（腰男性多见如肾小球肾炎、我的腰）

2.类型

膨出型	纤维环部分破裂、但表层完整
突出型	纤维环完全破裂、髓核突向椎管，后纵韧带完整
脱出型	髓核突破后纵韧带、髓核根部在椎间隙内
游离型	髓核与原椎间盘完全脱离
许莫氏 Schmorl 结节	髓核经上下软骨终板的裂隙突入椎体内
经骨突出型	髓核沿软骨终板和椎体之间的血管通道向前纵韧带突出



内层破裂
外层完好



许莫氏Schmorl结节

神经根受压(腰椎间盘突出症)

3.临床表现和治疗

非结构性脊柱侧凸:神医说知无不言

①腰痛（窦椎神经）+下肢放射痛（坐骨神经），腰部活动受限尤其前屈，腰椎侧凸（内奸外患）

髓核突出在神经根的内侧,腰椎凸向健侧,弯向患侧
髓核突出在神经根的外侧,腰椎凸向患侧,弯向健侧